



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 13745 DEL 17/12/2025

STRUTTURA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA

OGGETTO

PNRR Missione 6, Componente 2, l'Investimento 1.3.2 "Infrastruttura tecnologica del MdS, analisi di dati e modello predittivo per garantire i LEA e di sorveglianza e vigilanza sanitaria". Approvazione del tracciato definitivo del flusso informativo sanitario SIOC.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento, come previsto dal Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n.138 del 30 settembre 2025, si approva il tracciato definito del flusso informativo per il monitoraggio delle attività erogate dagli ospedali di comunità (SIOC) PNRR Missione 6, Componente 2, l'Investimento 1.3.2 "Infrastruttura tecnologica del MdS, analisi di dati e modello predittivo per garantire i LEA e di sorveglianza e vigilanza sanitaria".

IL DIRETTORE

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, recante: «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante: «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza», che abroga e sostituisce interamente il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2001 sul medesimo oggetto;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, che approva il «Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera», e in particolare l'allegato 1, paragrafo 10 «Continuità ospedale-territorio» e 10.1 «Ospedale di comunità»;

VISTO il decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, con oggetto «Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale» e in particolare l'allegato 1, paragrafo 11 «Ospedale di comunità»;

CONSIDERATO CHE l'istituzione di un flusso informativo per il monitoraggio dell'assistenza territoriale erogata dagli ospedali di comunità è un obiettivo specificatamente previsto dal PNRR Missione 6, Componente 2, Investimento 1.3.2 "Infrastruttura tecnologica del MdS, analisi di dati e modello predittivo per garantire i LEA e di sorveglianza e vigilanza sanitaria";

DATO ATTO CHE la Regione del Veneto ha approvato il Piano regionale in attuazione del PNRR – Missione 6, Componente 2, Investimenti 1 e 2 con deliberazioni n. 368 del 08/04/2022, n. 622 del 27/05/2022, n. 287 del 21/03/2023, n. 716 del 22/06/2023 e per l'intervento di cui trattasi sono stati stanziati alla Regione del Veneto la complessiva somma di euro 2.237.823,30 per la realizzazione di tutti e quattro i flussi informativi;

PREMESSO CHE la Regione del Veneto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2683 del 29 dicembre 2014 ha approvato il tracciato del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata e degli indicatori di attività e risultato per Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali e con successivo Decreto del Direttore

dell'unità organizzativa strutture intermedie e socio - sanitarie territoriali n. 1 del 10 ottobre 2016 ha approvato il documento tecnico che disciplina le modalità di gestione informatica per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso l'ODC e URT;

RILEVATO CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 1249 del 1 settembre 2020 è stata approvata la nomina di Azienda Zero quale Responsabile del Trattamento, ex art. 4, punto 8 del Regolamento UE 2016/679 dei flussi informativi riportati nell'allegato B alla medesima, tra cui risulta anche il flusso per il monitoraggio degli Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali – ODC e URT;

VISTO il decreto del Ministero della salute del 4 agosto 2025 che approva l'Istituzione del Sistema informativo per il monitoraggio delle attività erogate dagli ospedali di comunità - SIOC.

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n.138 del 30 settembre 2025 che approva l'adozione del flusso informativo sanitario SIOC, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale di cui sopra, incaricando il direttore della Direzione Programmazione Sanitaria dell'approvazione con proprio atto del tracciato aggiornato e definitivo;

CONSIDERATA la necessità di dedicare il flusso SIOC esclusivamente al monitoraggio delle attività erogate dagli ospedali di comunità, destinando altresì la rilevazione dell'attività erogata presso le strutture intermedie Unità Riabilitative Territoriali dal flusso ODC-URT al flusso istituito per il monitoraggio della riabilitazione territoriale SIAR (ai sensi del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 123 del 28 settembre 2023);

RILEVATA, dunque, la necessità di approvare il tracciato definitivo del flusso informativo sanitario SIOC, di cui all'**Allegato A**, al fine di implementare lo stesso in maniera progressiva a partire dal 1 gennaio 2026 e conseguentemente provvedere alla graduale eliminazione del flusso ODC-URT nel corso dello stesso anno 2026;

DECRETA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di approvare il tracciato definitivo del flusso informativo per il monitoraggio delle attività erogate dagli ospedali di comunità (SIOC) così come previsto nell'**Allegato A** al presente atto a partire dal 1 gennaio 2026;
3. di incaricare Azienda Zero di provvedere all'implementazione dell'infrastruttura per l'accoglimento del nuovo flusso SIOC, garantendo allo stesso tempo la disponibilità del sistema di accoglimento ODC-URT per il completamento della rilevazione dell'anno 2025 da parte delle Aziende;
4. di incaricare Azienda Zero di mantenere aggiornato il tracciato record, di cui al punto 2, in linea con le specifiche tecniche del Ministero e con le indicazioni regionali in materia, mettendo a disposizione la documentazione sul flusso SIOC in una sezione dedicata del Datawarehouse regionale;
5. di demandare alle Aziende Sanitarie in cui insistono le strutture intermedie pubbliche e private accreditate della Regione del Veneto, tenute alla trasmissione del flusso informativo SIOC, l'implementazione informatica dello stesso e tutti gli adempimenti conseguenti;
6. di dare atto che la prima trasmissione del flusso informativo SIOC, da parte delle suddette Aziende Sanitarie, dovrà essere effettuata entro il 31 marzo 2026;
7. di incaricare Azienda Zero del monitoraggio periodico dello stato di implementazione del flusso SIOC da parte delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto;
8. di incaricare Azienda Zero dell'implementazione dell'infrastruttura informatizzata per l'accoglienza del flusso e la sua successiva gestione secondo le tempistiche di trasmissione previste, oltre all'attività di aggiornamento nel sistema REGIS;
9. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente atto;
11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Dr.ssa Romina Cazzaro

Firma CAZZARO ROMINA
Data 17-12-2025



SERVIZIO
Socio Sanitario
Regionale



**Sistema informativo
per il monitoraggio delle attività
erogate dagli ospedali di comunità - SIOC**

TRACCIATO RECORD REGIONALE



**Tracciato Sistema informativo per il monitoraggio
delle attività erogate dagli ospedali di comunità - SIOC
Regione del Veneto**



N	Chiave	Descrizione Campo	LUNGH.	POS. INIZ.	TIPO	OBB	Istruzioni per la codifica
1. TRACCIATO DATI ANAGRAFICI ASSISTITO							
1.1	X	Numero della scheda di ricovero (ex Identificativo univoco assistito per episodio di accoglimento)	20	1	AN	OBB	Le prime 2 cifre identificano l'anno di ingresso, le altre 6 corrispondono alla numerazione progressiva di ricovero all'interno dell'anno. Il codice da utilizzare è articolato in: 1) la parte numerazione (ultime 6 cifre) deve essere numerica e ≠ 0; 2) le prime 2 cifre devono essere uguali all'anno di ricovero Il numero deve essere univoco per la struttura erogatrice e non deve mai ripetersi nel corso dell'anno Tali istruzioni di codifica si applicano a partire dai ricoveri in ODC dell'anno 2026. I ricoveri con data inizio nel 2025, che si concluderanno nell'anno 2026, mantengono l'ID già assegnato in fase di ricovero (ex campo "Identificativo univoco assistito per episodio di accoglimento" come da All. B DDR n.1 del 10/10/2016).
1.2		Codice fiscale o altro codice identificativo utente	20	21	AN	OBB	Il campo va valorizzato con il Codice Fiscale per tutte le schede riferite a cittadini italiani. Per i cittadini stranieri, qualora non in possesso del Codice Fiscale, vanno indicati in alternativa tra loro il codice TEAM (Tessera europea assicurazione malattia), o il codice ENI (Europei non iscritti), o il codice STP (Straniero temporaneamente presente). Per le prestazioni coperte da riservatezza ai sensi di legge il campo deve essere compilato con il carattere "A" ripetuto 20 volte.
1.3		Tipo identificativo utente	2	41	AN	OBB	Indica il tipo dell'identificativo del beneficiario della prestazione. I valori da indicare sono: 01. Codice fiscale 02. Codice ENI 03. Codice STP 04. Codice ID utente della Tessera Europea d'Assicurazione Malattia (TEAM) 05. Altro identificativo 09. Identificativo non disponibile 97. codice STP non presente in anagrafica 98. Assistito richiedente l'anonimato
1.4		Codice istituzione pagatrice TEAM (tessera europea)	28	43	AN	NBB	Indica il codice di identificazione assegnato a livello nazionale alla istituzione di assicurazione o di residenza competente ai sensi degli allegati 2 e 3 al regolamento 574/72. Come previsto nella Tessera Europea di Assicurazione Malattia (Il numero di istituzione pagatrice è riportato sotto quello di identificazione personale.) Da compilare se "Tipo identificativo utente" = 4 Non compilare nei casi coperti da riservatezza ai sensi di legge
1.5		MPI	28	71	AN	FAC	Master Patient Index (Id regionale della posizione anagrafica). Chiave di identificazione univoca con cui la posizione anagrafica è stata censita in ambiente regionale (Anagrafe Unica). Disponibile per i residenti e assistiti in Regione Veneto, come servizio erogato dalla anagrafe unica regionale. Non compilare nei casi coperti da riservatezza ai sensi di legge
1.6		Codice sanitario	9	99	AN	FAC	Il campo va valorizzato, in combinazione con il codice fiscale, per i soli residenti in Veneto. Non compilare nei casi coperti da riservatezza ai sensi di legge
1.7		Cognome	30	108	AN	FAC	Campo da valorizzare, in lettere maiuscole. Nei casi coperti da riservatezza ai sensi di legge dovrà essere posta la dicitura ANONIMO.
1.8		Nome	30	138	AN	FAC	Campo da valorizzare, in lettere maiuscole. Nei casi coperti da riservatezza ai sensi di legge dovrà essere posta la dicitura ANONIMO.
1.9		Data di nascita	8	168	Data	OBB	Utilizzare il formato GGMMAAAA. Non valorizzare nei casi in cui è previsto il mantenimento dell'anonimato.
1.10		Genere	1	176	AN	OBB	Utilizzare i codici seguenti: 1 – maschio, 2 – femmina, 3 - non specificato
1.11		Cittadinanza	3	177	AN	OBB	Identifica la cittadinanza dell'assistito al momento dell'ammissione. Per i cittadini italiani codificare con 100. Per gli altri cittadini stranieri utilizzare il codice stati esteri definito dal Ministero dell'Interno per l'anagrafe della popolazione. Per gli apolidi codificare 999.
1.12		Titolo di studio	1	180	AN	OBB	Titolo di studio conseguito dall'utente al momento dell'ammissione. Valori ammessi: 1. Nessun titolo (meno di 5 anni di studio) 2. Licenza elementare (5 anni di studio) 3. Diploma di scuola media inferiore (8 anni di studio) 4. Diploma di scuola media superiore (Qualifica professionale / Maturità) (13 anni di studio) 5. Diploma universitario o laurea breve 6. Laurea o superiore (17 o più anni di studio) 7. scuola professionale 9. sconosciuto
1.13		Regione di Residenza	3	181	AN	OBB	Indica la Regione di residenza dell'assistito. Per la codifica utilizzare il Codice Regioni di 3 caratteri definito con DM 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 1986, e successive modifiche. Se Stato estero valorizzare con 999.
1.14		Azienda ULSS di Residenza	3	184	AN	OBB	Indica l'Azienda ULSS di residenza dell'assistito al momento dell'ingresso in struttura. Se stato estero valorizzare con 999.
1.15		Comune/Stato estero di Residenza	6	187	AN	OBB	Indica il comune italiano, oppure eventualmente lo stato estero, presso il quale il paziente risulta legalmente residente alla ammissione. Codici ISTAT (primi 3 caratteri per la provincia e i rimanenti 3 caratteri per il progressivo comune). Si raccomanda di non omettere la rilevazione dello "0" costituente il primo carattere del codice provincia. Per i residenti all'estero codificare 999 i primi 3 caratteri ed il codice stato estero nei successivi 3, utilizzando il codice stati esteri definito dal Ministero dell'Interno per l'anagrafe della popolazione.
1.16		Stato civile	2	193	AN	OBB	Stato civile del paziente al momento del ricovero. Valori ammessi 01. Celibe/nubile 02. Coniugato/a 03. Separato/a 04. Divorziato/a 05. Vedovo/a 06. Unito/a civilmente 07. Già in unione civile (in decesso del partner) 08. Già in unione civile (per scioglimento unione) 09. Non rilevato (non è stata posta la domanda al paziente) 99. Dato mancante (è stata posta la domanda al paziente e non ha risposto)
1.17	X	Codice Azienda	6	195	AN	OBB	CAMPO CHIAVE Il campo deve essere valorizzato con i codici a SEI caratteri della azienda sanitaria in cui è ubicata la struttura OdC (050501,...).
1.18	X	Codice Struttura	6	201	AN	OBB	CAMPO CHIAVE I codici da utilizzare sono quelli indicati nei modelli ministeriali STS11



**Tracciato Sistema informativo per il monitoraggio
delle attività erogate dagli ospedali di comunità - SIOC
Regione del Veneto**



N	Chiave	Descrizione Campo	LUNGH.	POS. INIZ.	TIPO	OBB	Istruzioni per la codifica
---	--------	-------------------	--------	------------	------	-----	----------------------------

2. TRACCIATO ADT

2.1	X	Numero della scheda di ricovero (ex Identificativo univoco assistito per episodio di accoglimento)	20	1	AN	OBB	Le prime 2 cifre identificano l'anno di ingresso, le altre 6 corrispondono alla numerazione progressiva di ricovero all'interno dell'anno. Il codice da utilizzare è articolato in: 1) la parte numerazione (ultime 6 cifre) deve essere numerica e ≠ 0; 2) le prime 2 cifre devono essere uguali all'anno di ricovero Il numero deve essere univoco per la struttura erogatrice e non deve mai ripetersi nel corso dell'anno Tali istruzioni di codifica si applicano a partire dai ricoveri in ODC dell'anno 2026. I ricoveri con data inizio nel 2025, che si concluderanno nell'anno 2026, mantengono l'ID già assegnato in fase di ricovero (ex campo "Identificativo univoco assistito per episodio di accoglimento" come da All. B DDR n.1 del 10/10/2016).
2.2		Provenienza del Paziente	2	21	AN	OBB	Indica la struttura o il luogo di provenienza dell'assistito. I valori ammessi sono: 01. Domicilio dell'assistito con ADI (o SAD) 02. Domicilio dell'assistito senza ADI (o SAD) 03. Struttura socio-sanitaria residenziale extraospedaliera 04. Struttura sociale (es. Casa albergo per anziani) 05. Struttura ospedaliera pubblica 06. Altra struttura di cure intermedie (URT) 07. Paziente COVID19 proveniente da ospedale 08. Paziente COVID19 proveniente da struttura socio-sanitaria residenziale extraospedaliera 09. Altro 10. Ospedale privato 11. Hospice 12. Altro ospedale di comunità 13. Pronto Soccorso
2.3		Tipologia di ricovero	1	23	AN	OBB	Indica la tipologia di ricovero 1. Ospedale di Comunità
2.4		Data richiesta accoglimento	8	24	Data	OBB	Indicare la data di dichiarazione di eleggibilità al ricovero (inserimento in lista di attesa del paziente valutato ed eleggibile). Utilizzare il formato GGMMAAAA.
2.5		Data di ricovero	8	32	Data	OBB	Data del ricovero in struttura. La data deve essere minore o uguale alla "data di dimissione". Utilizzare il formato GGMMAAAA.
2.6		Data di dimissione o di decesso	8	40	Data	OBB	Data della dimissione dalla struttura, o del decesso in struttura. Utilizzare il formato GGMMAAAA.
2.7		Modalità di dimissione	1	48	AN	OBB	Individua lo stato del paziente al momento della dimissione, e l'eventuale continuazione del percorso assistenziale in altre strutture, codificato con i valori di dominio indicati nelle specifiche funzionali. 1. Domicilio dell'assistito con ADI (o SAD) 2. Domicilio dell'assistito senza ADI (o SAD) 3. Struttura socio-sanitaria residenziale extraospedaliera 4. Struttura sociale (es. Casa albergo per anziani) 5. Struttura ospedaliera 6. Altre strutture di Cure Intermedie (ODC, URT, Hospice) 7. Dimissione volontaria 8. Decesso 9. Dimissione protetta con attivazione rete cure palliative (Hospice, Cure Palliative Domiciliari ecc.) 0. Dimissione protetta al domicilio con attivazione altri servizi
2.8		Struttura erogatrice. Codice regionale dell'UDO	6	49	N	OBB	Indica il codice regionale della struttura erogatrice.
2.9		Struttura erogatrice. Codice MRA	15	55	AN	FAC	Campo che verrà valorizzato con la codifica MRA non appena disponibile.
2.10		Azienda ULSS pagante	6	70	AN	NBB	Indica l'Azienda ULSS pagante la quota sanitaria giornaliera. Il formato del campo è il seguente: le prime tre cifre rappresentano il codice regione, le seconde tre il numero di Azienda sanitaria.
2.11		Soggetto pagante la quota alberghiera	1	76	AN	NBB	Il campo va compilato solo quando è prevista la compartecipazione, come definito dalla DGR 2621/2012. I valori previsti sono: 1. Utente (in toto o con la compartecipazione della famiglia) 2. Utente (parzialmente, con la compartecipazione del Comune) 3. Comune (in toto) 4. Altro
2.12		Emissione quote	1	77	AN	OBB	Il campo integra la DGR 2683/2014 per rilevare la presenza di utenti solventi in proprio, non a carico del Sistema sanitario regionale I valori previsti sono: 1. Utente con quota totalmente a carico del SSR 2. Utente pagante in proprio
2.13		Problemi socio - familiari 1	2	78	AN	OBB	Segnalazione dei problemi di natura socio-familiare rilevati al momento del ricovero, codificato con i valori di dominio indicati nelle specifiche tecniche. Valori ammessi: 00 = Nessun problema rilevato 01 = In carico ai servizi sociali 02 = Problemi relazionali/comportamentali/psichiatrici 03 = Dipendenze 04 = Problemi di autonomia, disabilità fisica 05 = Problemi di carattere giudiziario 06 = Difficoltà economiche 07 = Difficoltà abitative 08 = Vive solo/a 09 = Assenza o inadeguatezza del caregiver 10 = Presenza amministratore di sostegno/tutore 99 = Dato mancante
2.14		Problemi socio - familiari 2	2	80	AN	OBB	Valori ammessi: vedi campo 2.12
2.15		Problemi socio - familiari 3	2	82	AN	OBB	Valori ammessi: vedi campo 2.12
2.16		Problemi socio - familiari 4	2	84	AN	OBB	Valori ammessi: vedi campo 2.12
2.17		Problemi socio - familiari 5	2	86	AN	OBB	Valori ammessi: vedi campo 2.12
2.18		Problemi socio - familiari 6	2	88	AN	OBB	Valori ammessi: vedi campo 2.12
2.19		Problemi socio - familiari 7	2	90	AN	OBB	Valori ammessi: vedi campo 2.12



**Tracciato Sistema informativo per il monitoraggio
delle attività erogate dagli ospedali di comunità - SIOC
Regione del Veneto**

N	Chiave	Descrizione Campo	LUNGH.	POS. INIZ.	TIPO	OBB	Istruzioni per la codifica
2.20		Problemi socio - familiari 8	2	92	AN	OBB	Valori ammessi: vedi campo 2.12
2.21		Problemi socio - familiari 9	2	94	AN	OBB	Valori ammessi: vedi campo 2.12
2.22		Problemi socio - familiari 10	2	96	AN	OBB	Valori ammessi: vedi campo 2.12
2.23		Soggetto proponente il ricovero	1	98	AN	OBB	Identifica il soggetto che ha richiesto il ricovero in struttura, codificato con i valori di dominio indicati nelle specifiche tecniche. Valori ammessi: 1 = medico di medicina generale; 2 = medico di continuità assistenziale; 3 = medico specialista ambulatoriale territoriale o ospedaliero; 4 = medico del pronto soccorso; 5 = pediatra di libera scelta.
2.24		Soggetto segnalante al medico la possibilità di ricovero	1	99	AN	FAC	Indica se il caso sia stato segnalato al medico da un soggetto qualificato differente da quelli indicati nel campo "Soggetto proponente il ricovero". Valori ammessi: 1 = Infermiere 2 = Assistente Sociale 3 = Altra tipologia di medico non compresa nel campo "Soggetto proponente il ricovero" 4 = Caregiver 5 = Altro operatore dell'assistenza domiciliare 9 = Altro
2.25		Indicare se il ricovero sia stato mediato attraverso le attività delle centrali operative territoriali (COT)	1	100	AN	OBB	Indica se, nel processo di valutazione dell'opportunità di ricoverare il paziente presso l'ospedale di comunità, abbia avuto un ruolo attivo una COT. Valori ammessi: 1 = SI 2 = NO
2.26		Codice COT	12	101	AN	FAC	Indica, qualora il ricovero sia stato mediato da una COT, la concatenazione del codice identificativo della Regione, della ASL e codice STS11.
2.27		Giornate di assenza temporanea	3	113	N	OBB	Numero di giornate nelle quali il paziente, durante il ricovero, è temporaneamente assente. Se paziente assente per meno di 24 ore si considera 1 giorno di assenza. Nel caso in cui l'assenza temporanea esiti in ricovero in altra struttura, il ricovero in ODC deve essere chiuso utilizzando la modalità di dimissione più appropriata.
2.28		Motivo principale del ricovero	2	116	AN	OBB	Identifica il motivo principale che ha determinato la necessità del ricovero, codificato con i valori di dominio indicati nelle specifiche funzionali. Valori ammessi: 01 = Sorveglianza e assistenza infermieristica continuativa 02 = Patologia cronica riacutizzata 03 = Monitoraggio clinico e stabilizzazione terapeutica 04 = Educazione/addestramento del paziente e del caregiver 05 = Riattivazione funzionale 06 = Interventi riabilitativi/rieducativi/monodistretto o completamento di interventi estensivi 07 = Acuzie minori 08 = Isolamento per patologia infettiva 99 = Altro
2.29		Codice Regione struttura di provenienza	3	118	AN	NBB	Se valore campo "Provenienza del Paziente" è diverso da "01" o "02", indica il codice identificativo della Regione dove si trova la struttura di provenienza del paziente. Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri definito con DM 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 15 ottobre 1986, e successive modifiche, utilizzato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali. Utilizzare 999 se proveniente da strutture all'estero.
2.30		Codice ASL struttura di provenienza del paziente	3	121	AN	NBB	Se valore campo "Codice Regione struttura di provenienza" è diverso da "999" e campo "Provenienza del Paziente" diverso da "01" o "02" e regione di provenienza del paziente "Codice Regione struttura di provenienza" coincide con la regione inviante, indica il codice identificativo dell'Azienda dove si trova la struttura di provenienza del paziente. Il campo deve essere valorizzato con i codici a tre caratteri dell'Azienda sanitaria in cui è ubicata la struttura ODC.
2.31		Codice struttura di provenienza del paziente	6	124	AN	NBB	Se valore campo "Codice Regione struttura di provenienza" è diverso da "999" e campo "Provenienza del Paziente" diverso da "01", "02", "04" o "09" e il campo "Codice Regione struttura di provenienza" coincide con la regione inviante, indica il codice identificativo della struttura di provenienza del paziente. I codici da utilizzare sono quelli indicati nei modelli ministeriali HSP11, RIA11, STS11. Inserire 999999 se dato mancante.
2.32		Codice diagnosi 1	7	130	AN	OBB	Identifica le patologie di cui il paziente è affetto, o condizioni nelle quali si trova (fino a un massimo di 6) utilizzando la codifica ICD9CM. Compilare alla dimissione. Valori ammessi: ICD9-CM - il codice prevede sotto-classificazioni o sottocategorie; - se la patologia prevede un genere specifico, il sesso del paziente deve essere coerente con quello previsto per la diagnosi; - se la patologia prevede un range di età di validità, l'età del paziente deve essere compresa in questo range; - non è possibile indicare la stessa diagnosi più volte (con progressivi diversi).
2.33		Codice diagnosi 2	7	137	AN	NBB	Vedi campo precedente
2.34		Codice diagnosi 3	7	144	AN	NBB	Vedi campo precedente
2.35		Codice diagnosi 4	7	151	AN	NBB	Vedi campo precedente
2.36		Codice diagnosi 5	7	158	AN	NBB	Vedi campo precedente
2.37		Codice diagnosi 6	7	165	AN	NBB	Vedi campo precedente
2.38		Codice procedura 1	8	172	AN	FAC	Identifica gli interventi e le procedure effettuati/e durante il ricovero (fino ad un massimo di 11) utilizzando la codifica ICD9CM e successive modificazioni o integrazioni. Compilare alla dimissione.
2.39		Codice procedura 2	8	180	AN	FAC	Vedi campo precedente
2.40		Codice procedura 3	8	188	AN	FAC	Vedi campo precedente
2.41		Codice procedura 4	8	196	AN	FAC	Vedi campo precedente
2.42		Codice procedura 5	8	204	AN	FAC	Vedi campo precedente
2.43		Codice procedura 6	8	212	AN	FAC	Vedi campo precedente



**Tracciato Sistema informativo per il monitoraggio
delle attività erogate dagli ospedali di comunità - SIOC
Regione del Veneto**



N	Chiave	Descrizione Campo	LUNGH.	POS. INIZ.	TIPO	OBB	Istruzioni per la codifica
2.44		Codice procedura 7	8	220	AN	FAC	Vedi campo precedente
2.45		Codice procedura 8	8	228	AN	FAC	Vedi campo precedente
2.46		Codice procedura 9	8	236	AN	FAC	Vedi campo precedente
2.47		Codice procedura 10	8	244	AN	FAC	Vedi campo precedente
2.48		Codice procedura 11	8	252	AN	FAC	Vedi campo precedente
2.49	X	Codice Azienda	6	260	AN	OBB	CAMPO CHIAVE Il campo deve essere valorizzato con i codici a SEI caratteri della azienda sanitaria in cui è ubicata la struttura OdC (050501,...).
2.50	X	Codice Struttura	6	266	AN	OBB	CAMPO CHIAVE I codici da utilizzare sono quelli indicati nei modelli ministeriali STS11

3. TRACCIATO VALUTAZIONE

3.1	X	Numero della scheda di ricovero (ex Identificativo univoco assistito per episodio di accoglimento)	20	1	AN	OBB	Le prime 2 cifre identificano l'anno di ingresso, le altre 6 corrispondono alla numerazione progressiva di ricovero all'interno dell'anno. Il codice da utilizzare è articolato in: 1) la parte numerazione (ultime 6 cifre) deve essere numerica e ≠ 0; 2) le prime 2 cifre devono essere uguali all'anno di ricovero Il numero deve essere univoco per la struttura erogatrice e non deve mai ripetersi nel corso dell'anno Tali istruzioni di codifica si applicano a partire dai ricoveri in ODC dell'anno 2026. I ricoveri con data inizio nel 2025, che si concluderanno nell'anno 2026, mantengono l'ID già assegnato in fase di ricovero (ex campo "Identificativo univoco assistito per episodio di accoglimento" come da All. B DDR n.1 del 10/10/2016).
3.2	X	Numero di valutazione	20	21	AN	OBB	Codice identificativo univoco assegnato alla valutazione sull'assistito ed inserito nell'archivio aziendale delle valutazioni.
3.3		Momento valutazione	1	41	AN	OBB	I valori ammessi sono 1. Ricovero 2. Dimissione
3.4		Data valutazione	8	42	D	OBB	Indica la data di valutazione. Utilizzare il formato GGMMAAAA.
3.5		SVAMA Patologia prevalente	3	50	AN	OBB	Vedi valore del codice ICPC, assegnato alla patologia prevalente, in scheda SVaMA aggiornata (DGR 96/2025, Allegato A). Per pazienti COVID utilizzare obbligatoriamente nella valutazione all'ingresso il codice ICPC: R83-Altre infezioni del sistema respiratorio
3.6		SVAMA Patologia concomitante	3	53	AN	FAC	Vedi valore del codice ICPC, assegnato alla patologia concomitante in scheda SVaMA aggiornata (DGR 96/2025, Allegato A).
3.7		SVAMA Patologia concomitante 2	3	56	AN	FAC	Vedi valore del codice ICPC, assegnato alla seconda patologia concomitante in scheda SVaMA aggiornata (DGR 96/2025, Allegato A).
3.8		SVAMA Barthel - alimentazione	2	59	N	OBB	I valori ai fini della definizione della situazione funzionale (Indice di Barthel) sono ricavati dalla SVaMA (DGR 96/2025, Allegato A). Sono omessi in caso di dimissione per decesso. I valori ammessi per questo campo sono: 00, 02, 05, 08, 10. Tutti i valori dell'indice di Barthel sono conferiti secondo le regole di SVaMA. Se il paziente è deceduto (2.7="8"), compilare con 99.
3.9		SVAMA Barthel ADL - bagno/doccia	1	61	N	OBB	I valori ammessi per questo campo sono: 0, 1, 2, 4, 5. Se il paziente è deceduto (2.7="8"), compilare con 9.
3.10		SVAMA Barthel ADL - igiene personale	1	62	N	OBB	I valori ammessi per questo campo sono: 0, 1, 2, 4, 5. Se il paziente è deceduto (2.7="8"), compilare con 9.
3.11		SVAMA Barthel ADL - abbigliamento	2	63	N	OBB	I valori ammessi per questo campo sono: 00, 02, 05, 08, 10. Se il paziente è deceduto (2.7="8"), compilare con 99.
3.12		SVAMA Barthel ADL - continenza intestinale	2	65	N	OBB	I valori ammessi per questo campo sono: 00, 02, 05, 08, 10. Se il paziente è deceduto (2.7="8"), compilare con 99.
3.13		SVAMA Barthel ADL - continenza urinaria	2	67	N	OBB	I valori ammessi per questo campo sono: 00, 02, 05, 08, 10. Se il paziente è deceduto (2.7="8"), compilare con 99.
3.14		SVAMA Barthel ADL - uso del gabinetto	2	69	N	OBB	I valori ammessi per questo campo sono: 00, 02, 05, 08, 10. Se il paziente è deceduto (2.7="8"), compilare con 99.
3.15		SVAMA Barthel MOB - letto/sedia/carrozzina	2	71	N	OBB	I valori ammessi per questo campo sono: 00, 03, 07, 12, 15. Se il paziente è deceduto (2.7="8"), compilare con 99.
3.16		SVAMA Barthel MOB - deambul./carrozzina	2	73	N	OBB	I valori ammessi per questo campo sono: 00, 03, 07, 10, 11, 12, 14, 15. Se il paziente è deceduto (2.7="8"), compilare con 99.
3.17		SVAMA Barthel MOB - uso carrozzina	1	75	N	OBB	Indicare se è stata utilizzata la scala USO della carrozzina. I valori sono: 0. no 1. si
3.18		SVAMA Barthel MOB - scale	2	76	N	OBB	I valori ammessi per questo campo sono: 00, 02, 05, 08, 10. Se il paziente è deceduto (2.7="8"), compilare con 99.



**Tracciato Sistema informativo per il monitoraggio
delle attività erogate dagli ospedali di comunità - SIOC
Regione del Veneto**



N	Chiave	Descrizione Campo	LUNGH.	POS. INIZ.	TIPO	OBB	Istruzioni per la codifica
3.19		SVAMA Assistenza Infermieristica	20	78	N	OBB	Condizioni che necessitano di prestazioni infermieristiche o specialistiche. Codificare alla dimissione solo se l'esito è diverso dal decesso. Codificare in questo modo: "1" in caso di prestazione erogata nel periodo; "0" in caso di prestazione assente nel periodo. La posizione del carattere si riferisce alla tipologia della prestazione (es. se presenti Cirrosi scompensata e PEG, la stringa sarà la seguente: 001001000000000000) erogata nel periodo. (compilare tutti i valori da 17 fino a 20 con 0; al momento sono da gestire i primi 16) Le posizioni sono le seguenti: 1. Diabete insulinodipendente, 2. Scompenso cardiaco in classe 3-4 NYHA con necessità di monitoraggio frequente del bilancio idrico (≥75 mg. Furosemide pro die), alimentare e parametri vitali (polso, pressione, frequenza cardiaca), 3. Cirrosi scompensata e altre forme di ascite con necessità come sopra elencate, 4. Tracheostomia, 5. Ossigenoterapia continuativa a lungo termine (>3 h al di), 6. Sondino naso-gastrico, gastrostomia (PEG), 7. Catetere venoso centrale o nutrizione parenterale totale o terapia infusionale quotidiana, 8. Catetere vescicale, 9. Ano artificiale e/o ureterostomia, 10. Nefrostomia o terapia peridurale a lungo termine o terapia antalgica con oppioidi che richiede adeguamento della posologia. 11. Ulcere da decubito (Ulcere distrofiche agli arti e/o altre lesioni della cute chirurgiche, traumatiche, oncologiche), 12. Respiratorie/Ventilazione Assistita, 13. Dialisi o dialisi peritoneale 14. Presenza di dolore (neoplastico o non neoplastico) 15. Dipendenza da apparecchiature elettromedicali 16. Paziente neoplastico allettato Le informazioni richieste sono presenti nella SVaMA, tabella valutazione sanitaria (DGR 96/2025, Allegato A).
3.20		SVAMA Assistenza Infermieristica (VIP)	2	98	N	OBB	Indicatore relativo alla necessità di assistenza infermieristica. Punteggio VIP della scheda SVAMA (DGR 96/2025, Allegato A). Valori ammessi 00, 05, 10, 15 ..., 80. Se il paziente è deceduto (2.7="8"), compilare con 99.
3.21		SVAMA Rischio decubiti (VPIA)	2	100	AN	OBB	Indicatore relativo al rischio decubiti. Punteggio VPIA della scheda SVAMA (DGR 96/2025, Allegato A). Il punteggio può essere attribuito anche direttamente con i seguenti valori: 00. Rischio non elevato di lesioni da decubito 10. Rischio elevato di lesioni da decubito (Usare indice di Exton Smith) 15. Presenza di una piaga 25. Presenza di due o più piaghe Se il paziente è deceduto (2.7="8"), compilare con 99.
3.22		SVAMA Area Cognitiva (VCOG)	2	102	N	OBB	Indica il livello di fragilità relativo all'area cognitiva e funzionale dell'assistito. Punteggio VCOG della scheda SVAMA (DGR 96/2025, Allegato A, Valutazione cognitiva e funzionale, esito del test SPMSQ). Se il paziente è deceduto (2.7="8"), compilare con 99.
3.23		SVAMA Supporto rete sociale (PSOC)	1	104	N	OBB	Indica l'eventuale presenza del supporto delle reti formali ed informali (famiglia, privato, vicinato e volontariato). Punteggio PSOC della scheda SVAMA (DGR 96/2025, Allegato A). I valori sono: 1. Ben assistito 2. Parzialmente assistito 3. Non sufficientemente assistito Se il paziente è deceduto (2.7="8"), compilare con 9.
3.24		Punteggio Karnofsky	2	105	N	OBB	Punteggio Karnofsky. Valori tra 00 a 90. Valore 00 (= morte) è consentito solo in caso di dimissione per decesso.
3.25		Traiettoria prognostica "Tp"	1	107	N	NBB	Valori da compilare solo al ricovero [3.3=1]. I valori sono: 1. Pazienti con funzioni/abilità perse ma recuperabili, da riabilitare 2. Pazienti con alcune funzionalità/abilità perse, da stabilizzare 3. Pazienti con alcune funzionalità/abilità sicuramente perse, in cure palliative
3.26		Esiti funzionali alla dimissione "Ef"	1	108	N	NBB	Valori da compilare solo alla dimissione [3.3=2]. I valori sono: 1. Funzioni recuperate 2. Funzioni stabilizzate 3. Funzioni peggiorate 4. Decesso
3.27		Numero di infezioni urinarie	2	109	N	OBB	Numero di infezioni urinarie verificate durante il ricovero. Il dato va consuntivato alla dimissione [campo obbligatorio se 3.3=2]. I valori da utilizzare sono compresi tra "0" e "99"
3.28		Numero di infezioni non urinarie	2	111	N	OBB	Numero di infezioni non urinarie verificate durante il ricovero. Il dato va consuntivato alla dimissione [campo obbligatorio se 3.3=2]. I valori da utilizzare sono compresi tra "0" e "99"
3.29		Numero di cadute lievi	2	113	N	OBB	Numero di cadute nell'intervallo di tempo, senza conseguenze o con conseguenze minori o lievi, trattate in struttura. Il dato va consuntivato alla dimissione [campo obbligatorio se 3.3=2]. Il valore da utilizzare è compreso tra "0" e "99".
3.30		Numero di cadute moderate	2	115	N	OBB	Numero di cadute nell'intervallo di tempo, con conseguenze moderate (accesso a PS o a prestazione diagnostica/specialistica, senza ricovero o frattura). Il dato va consuntivato alla dimissione [campo obbligatorio se 3.3=2]. Il valore da utilizzare è compreso tra "0" e "99".
3.31		Numero di cadute gravi	2	117	N	OBB	Numero di cadute nell'intervallo di tempo, con conseguenze gravi (con ricovero o frattura). Il dato va consuntivato alla dimissione [campo obbligatorio se 3.3=2]. Il valore da utilizzare è compreso tra "0" e "99".
3.32		Contenzione	1	119	N	OBB	Presenza di contenzione. Il dato va consuntivato alla dimissione [campo obbligatorio se 3.3=2]. I codici da utilizzare sono: 1. Nessuna 2. Diurna 3. Notturna 4. Continua



**Tracciato Sistema informativo per il monitoraggio
delle attività erogate dagli ospedali di comunità - SIOC
Regione del Veneto**



N	Chiave	Descrizione Campo	LUNGH.	POS. INIZ.	TIPO	OBB	Istruzioni per la codifica
3.33		SVAMA Presenza disturbi del comportamento (PCOMP)	1	120	AN	OBB	Indica la presenza o meno di disturbi comportamentali. Punteggio PCOMP della scheda SVAMA (DGR 96/2025, Allegato A, Profilo dell'autonomia). Valori ammessi: 1. Assente/Lieve 2. Moderato 3. Grave 9. Deceduto Se il paziente è deceduto (2.7="8"), compilare con 9.
3.34		Valutazione ADL con scala di Barthel	3	121	N	OBB	Se (valore data di ricovero – anno di nascita) >= 19, indica il punteggio individuale, secondo la scala "Indice di Barthel modificato", misurato all'ingresso in struttura. Il valore deve essere compreso fra 0 e 100. «Indice di Barthel modificato» in coerenza con quanto già rilevato in altri flussi NSIS (in particolare SDO-R). Da compilare nella valutazione all'ingresso Da compilare nella valutazione alla dimissione se valore campo "2.7 Modalità di dimissione" diverso da "8. Decesso". Se il paziente è deceduto (2.7="8"), compilare con 999.
3.48	X	Codice Azienda	6	124	AN	OBB	CAMPO CHIAVE Il campo deve essere valorizzato con i codici a sei caratteri della azienda sanitaria in cui è ubicata la struttura OdC (050501,...).
3.49	X	Codice Struttura	6	130	AN	OBB	CAMPO CHIAVE I codici da utilizzare sono quelli indicati nei modelli ministeriali STS11

4.1 TRACCIATO REGIONALE UDO

4.1	X	Struttura erogatrice. Codice regionale dell'UDO	6	1	N	OBB	Indica il codice regionale provvisorio della struttura erogatrice.
4.2		Struttura erogatrice. Codice regionale MRA	15	7	AN	OBB	Codifica della struttura secondo il progetto MRA (in corso di definizione)
4.3		Tipologia di UDO	1	22	N	OBB	Indica la tipologia di UDO. I codici da utilizzare sono: 1. Ospedale di Comunità
4.4		Modello assistenziale	1	23	N	OBB	Indica il modello assistenziale come definito per la struttura. I valori sono: 1. assistenza medica affidata a medici e personale specialista provenienti o incardinati nell'area geriatrica o internistica dell'ospedale o del territorio 2. struttura gestita dai MMG 3. struttura gestita con l'utilizzo di medici della continuità assistenziale 4. assistenza medica affidata a medici con specifiche capacità professionali della struttura o del Centro servizi.
4.5		Responsabile sanitario	1	24		OBB	Indica se il responsabile sanitario è incardinato presso: 1. Territorio 2. Ospedale
4.6		Denominazione dell'UDO	120	25	A	OBB	Denominazione dell'Unità di Offerta, come specificata nell'atto di autorizzazione o accreditamento.
4.7	X	Regione sede UDO	3	145	AN	OBB	Codice della Regione dove ha sede l'UDO. Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri definito con DM 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 15 ottobre 1986, e successive modifiche, utilizzato anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali.
4.8	X	ULSS sede UDO	3	148	AN	OBB	Codice della Azienda ULSS dove ha sede l'UDO. Il campo deve essere valorizzato con i codici a tre caratteri dell'Azienda sanitaria in cui è ubicata la struttura OdC.
4.9		Comune sede UDO	6	151	N	OBB	Codice ISTAT del Comune dove ha sede l'UDO.
4.10		Indirizzo UDO	30	157	A	OBB	Codici ISTAT (primi 3 caratteri per la provincia e i rimanenti 3 caratteri per il progressivo comune).
4.11		Codice regionale dell'Ente gestore	6	187	N	OBB	Indicare l'indirizzo fisico comprensivo di numero civico.
4.12		Denominazione dell'Ente gestore	120	193	AN	OBB	Indica il codice regionale dell'Ente Gestore. Utilizzare la stessa codifica di EG del flusso di cui alla DGR 2961/2012.
4.13		Ragione giuridica dell'Ente gestore	2	313	N	OBB	Denominazione dell'Ente Gestore. Indica la ragione giuridica dell'Ente titolare della gestione. La codifica è la seguente 1. ULSS 2. IPAB 3. Comune o Altro Ente locale 4. Azienda speciale 5. Fondazione 6. Società di capitali 7. Società cooperativa 8. Associazione non profit 9. Ente ecclesiastico 10. Altro
4.14		Comune sede EG	6	315	N	OBB	Codice ISTAT del Comune sede dell'EG.
4.15		Indirizzo EG	30	321	AN	OBB	Codici ISTAT (primi 3 caratteri per la provincia e i rimanenti 3 caratteri per il progressivo comune).
4.16		Partita IVA EG	11	351	N	OBB	Indicare l'indirizzo fisico comprensivo di numero civico
4.17		Codice fiscale EG	11	362	N	OBB	Numero di Partita IVA dell'Ente Gestore
4.18		Data inizio validità	8	373	D	OBB	Codice Fiscale dell'Ente Gestore
4.19		Data fine validità	8	381	D	OBB	Data di inizio validità del record anagrafico
4.19.1	X	COD_STRUT_EROG_STS	6	389	AN	OBB	Data di fine validità del record anagrafico Struttura erogatrice Codice STS11



Tracciato Sistema informativo per il monitoraggio
delle attività erogate dagli ospedali di comunità - SIOC
Regione del Veneto



N	Chiave	Descrizione Campo	LUNGH.	POS. INIZ.	TIPO	OBB	Istruzioni per la codifica
4.2 TRACCIATO REGIONALE ATTI LR 22/2002							
4.20	X	Struttura erogatrice. Codice regionale dell'UDO	6	1	N	OBB	Indica il codice regionale provvisorio della struttura erogatrice, in correlazione con il campo 4.1.
4.21		Struttura erogatrice. Codice regionale MRA	15	7	AN	OBB	Codifica della struttura secondo il progetto MRA (in corso di definizione)
4.22	X	ID atto	10	22	AN	OBB	Numero univoco del record del tracciato 4.2
4.23		Oggetto dell'atto	1	32	N	OBB	I valori sono: 1. Autorizzazione all'esercizio 2. Accreditamento
4.24		Tipologia dell'Atto	1	33	N	OBB	I valori sono: 1. Decreto dirigenziale 2. Deliberazione della Giunta regionale
4.25		Numero dell'atto	4	34	N	OBB	Numero intero dell'atto (DGR o DDR)
4.26		Data dell'atto	8	38	D	OBB	Data di approvazione/adozione dell'atto
4.27		Numero di posti	3	46	N	OBB	Numero di posti oggetti di autorizzazione/accreditamento.
4.28		Caratteristiche dell'atto	1	49	N	OBB	Il valore viene usato per rilevare se l'atto: 1. E' emesso per la prima volta 2. Modifica atto precedente integrando numero posti (in questo caso indicare nel campo XX solo il numero di posti aggiunti) 3. Revoca atto precedente definendo un nuovo totale dei posti 4. Rinnova atto precedente senza modificare contenuto 5. Modifica atto precedente senza variazioni del numero di posti (es. per variazioni EG, per variazioni di sede)
4.29		Data fine validità atto	8	50	D	FAC	Data di cessazione della validità dell'atto
4.30		ID atto revocante	10	58	AN	FAC	ID dell'atto di revoca del presente

Ultimo aggiornamento: 16 dicembre 2025.



**Tracciato Sistema informativo per il monitoraggio
delle attività erogate dagli ospedali di comunità - SIOC
Regione del Veneto**



	Si ricordano alcune regole generali di compilazione dei campi:
1)	I campi alfanumerici (a lunghezza variabile) vanno allineati a sinistra ed eventualmente completati con caratteri "spazio"; analogamente, se non valorizzati, essi devono contenere caratteri "spazio".
2)	I campi numerici vanno allineati a destra ed eventualmente completati con caratteri "zero"; analogamente, se non valorizzati, essi devono contenere caratteri "zero".
3)	I campi numerici contenenti importi devono avere una parte decimale comunque valorizzata mediante due caratteri. In posizione fissa sul terz'ultimo byte il carattere di separazione della parte decimale dalla parte intera deve essere il <u>punto</u> . E' vietato l'utilizzo di caratteri di separazione delle migliaia.
	OBB=Obbligatorio, FAC=Facoltativo, NBB=Obbligatorietà condizionata dalla compilazione di altri campi/condizioni

PERIODICITA' DI TRASMISSIONE DEL FLUSSO

SEZIONE	PERIODICITA'
1. TRACCIATO DATI ANAGRAFICI ASSISTITO	Mensile - entro il mese solare successivo alla data della dimissione del paziente
2. TRACCIATO ADT	Mensile - entro il mese solare successivo alla data della dimissione del paziente
3. TRACCIATO VALUTAZIONE	Mensile - entro il mese solare successivo alla data della dimissione del paziente
4.1 TRACCIATO REGIONALE UDO	Ad ogni aggiornamento - a cura di Azienda Zero
4.2 TRACCIATO REGIONALE ATTI LR 22/2002	Ad ogni aggiornamento - a cura di Azienda Zero
	Il flusso è a ricopertura (o incrementale): pertanto per i tracciati da 1 a 3 ad ogni fase deve essere inviata l'attività dall'inizio dell'anno fino alla fine della fase. Ad esempio in fase 2 deve essere inviata l'attività relativa a fase 1 e fase 2, in fase 10, l'attività relativa alle fasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Ultimo aggiornamento: 16 dicembre 2025.